



COMMENT VA VOTRE COEUR ?

Rapport d'Évaluation du Risque Cardiovasculaire
Date : 30 March 2026

AVERTISSEMENT

Ce rapport est à titre informatif et pédagogique uniquement. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale. Consultez votre médecin pour une évaluation personnalisée de votre risque cardiovasculaire.

1. PROFIL DU PATIENT

Sexe	Homme
Âge	52 ans
Poids	85 kg
Taille	178 cm
IMC	26.8 kg/m2 (Surpoids)
Tension artérielle	148/92 mmHg
Cholestérol total	6.8 mmol/L
Cholestérol HDL	1.1 mmol/L
Glycémie à jeun	1.05 g/L

2. RISQUE SCORE2 (SCORE2)

Le SCORE2 (Systematic Coronary Risk Evaluation 2) est l'algorithme de référence de la Société Européenne de Cardiologie (ESC 2021) pour estimer le risque à 10 ans d'événement cardiovasculaire majeur (décès CV, infarctus, AVC) chez les personnes sans antécédent cardiovasculaire.

9.3%

Risque à 10 ans : Élevé

Échelle de risque :



3. ÉVALUATION QUALITATIVE MULTI-FACTEURS

Cette évaluation prend en compte l'ensemble de vos facteurs de risque (mode de vie, antécédents, données médicales) pour établir un profil de risque global basé sur les données épidémiologiques internationales.

RISQUE MODÉRÉ À ÉLEVÉ

Score : 68/108 (63.0%)

Détail par facteur de risque :

FACTEUR	VALEUR	POINTS	JAUGE
Âge	52	5/14	
Sexe	Homme	5/5	
IMC	26.8 (Surpoids)	2/6	
Antécédents familiaux	oui	5/5	
Sédentarité (temps assis)	>7h	5/5	
Activité physique	<30min	2/2	
Tabac actif	oui	9/9	
Tabac passif	oui	2/2	
Fruits et légumes	2-5/sem	2/3	
Ajout de sel	oui	1/1	
Préparation des repas	industriel	3/3	
Charcuterie/Fromage régulier	oui	3/3	
Stress	permanent	7/7	
Colères / hostilité	frequent	2/3	
Charge familiale seul(e)	non	0/2	
Alcool excessif	non	0/3	
Boissons énergisantes	oui	1/1	
Hypertension	oui	6/10	
Cholestérol élevé	oui	5/9	
Diabète	non	0/7	
Apnée du sommeil	non	0/5	
Troubles du sommeil	oui	3/3	

4. RECOMMANDATIONS PERSONNALISÉES

Voici les actions prioritaires pour améliorer votre santé cardiovasculaire, classées par ordre d'impact :

1. Perdre du poids : viser un IMC < 25 réduirait votre risque cardiovasculaire (HR 1.26, Lancet 2014).
2. Antécédents familiaux : surveillance cardiologique renforcée recommandée (HR 1.74, EPIC-Norfolk).
3. Réduire le temps assis : se lever toutes les 30 min. La sédentarité prolongée augmente le risque CV de 90% (HR 1.90, AHA 2016).
4. Augmenter l'activité physique : 30 min/jour de marche rapide. L'inactivité augmente le risque CV de 24% indépendamment des autres facteurs (HR 1.24, méta-analyse 2012). L'effet total est plus important car l'activité améliore aussi le poids, la tension et le cholestérol.
- !! ARRÊTER DE FUMER : le tabac multiplie le risque d'infarctus par 2.87 (INTERHEART, Lancet 2004). Après 1 an d'arrêt, le risque diminue de 50%. Après 5 ans, il rejoint celui d'un non-fumeur.
- !! Tabagisme passif : l'exposition augmente le risque CV de 25-30% (RR 1.25, He et al., NEJM 1999). Éviter les environnements enfumés.
7. Réduire le sel : ne pas resaler les plats. L'excès de sel augmente le risque CV de 13% (RR 1.13, Graudal 2020) et l'hypertension de 33%.
8. Privilégier la cuisine maison : les plats industriels sont riches en sel, sucre et graisses saturées (RR ~1.50 pour événements CV, Micha et al., Circulation 2010).
9. Limiter charcuterie et fromage : la viande transformée augmente le risque coronarien de 42% par 50g/jour (RR 1.42, Micha et al., Circulation 2010).
10. Gérer le stress chronique : le stress permanent multiplie le risque d'infarctus par 2.17 (INTERHEART, Rosengren et al., Lancet 2004). Méditation, activité physique, suivi psychologique recommandés.
11. Colères régulières : apprendre à gérer ses émotions réduit le risque cardiovasculaire.
12. Boissons énergisantes : risque d'arythmie et d'hypertension aiguë (Fletcher et al., JACC 2017). À éviter, surtout en cas de pathologie cardiaque.

13. Hypertension confirmée : risque d'infarctus multiplié par 1.91 (INTERHEART, Lancet 2004). Traitement et suivi régulier recommandés.
14. Cholestérol élevé : chaque +1 mmol/L augmente le risque coronarien de 52% (PSC, Lancet 2007). Adapter l'alimentation et consulter.
15. Troubles du sommeil : l'insomnie chronique augmente le risque CV de 45% (HR 1.45, He et al., Eur J Prev Cardiol 2017). Consultation spécialisée recommandée, hygiène du sommeil à améliorer.

5. MÉTHODOLOGIE & RÉFÉRENCES

Algorithme SCORE2 (mode quantitatif)

SCORE2 (Systematic Coronary Risk Evaluation 2) est un algorithme développé, calibré et validé par la Société Européenne de Cardiologie (ESC) pour prédire le risque à 10 ans d'un premier événement cardiovasculaire dans les populations européennes. Le modèle utilise 5 variables : âge, statut tabagique, pression artérielle systolique, cholestérol total et cholestérol HDL.

Il est calibré pour 4 régions de risque en Europe. La France appartient à la région à bas risque. Les coefficients utilisés sont issus de la publication originale dans le European Heart Journal (2021).

Pour les patients de 70-89 ans, le modèle SCORE2-OP (Older Persons) est utilisé, avec des coefficients adaptés à cette tranche d'âge.

Formule : $Risque = 1 - S0^{exp(LP)}$ puis calibration régionale
où LP = somme des (coefficient x variable centrée)
et S0 = survie de base à 10 ans.

Seuils de risque SCORE2 :

TRANCHE D'ÂGE	FAIBLE-MODÉRÉ	ÉLEVÉ	TRÈS ÉLEVÉ
< 50 ans (SCORE2)	< 2.5%	2.5 - 7.5%	>= 7.5%
50-69 ans (SCORE2)	< 5%	5 - 10%	>= 10%
>= 70 ans (SCORE2-OP)	< 7.5%	7.5 - 15%	>= 15%

Modèle qualitatif multi-facteurs (mode pédagogique)

Le mode qualitatif évalue 23 facteurs de risque pondérés proportionnellement au logarithme du risque relatif (ln(RR)) publié dans la littérature médicale. Les sources incluent INTERHEART (Lancet 2004, 52 pays), la Prospective Studies Collaboration (Lancet 2002, 1M adultes), l'Emerging Risk Factors Collaboration (Lancet 2010, 102 études) et d'autres méta-analyses de référence.

Les facteurs évalués couvrent : le profil (âge, sexe, IMC), l'hérédité, le mode de vie (sédentarité, activité physique, tabac, alimentation, stress, colères, alcool, sommeil) et les données médicales (HTA, cholestérol, diabète, apnée).

Chaque facteur reçoit un score de 0 (pas de risque) au maximum de sa pondération. Le score total est normalisé sur 100 et classé en 6 catégories de risque.

Pondérations des facteurs :

FACTEUR	POIDS	JUSTIFICATION
Âge	14 pts	HR ~2.5/décennie (PSC, Lancet 2002)
Hypertension	10 pts	HR 2x-4x (PSC, Lancet 2002)
Tabac actif	9 pts	OR 2.87 (INTERHEART, Lancet 2004)
Cholestérol	9 pts	OR 3.25 top quintile (INTERHEART 2004)
Stress	7 pts	OR 2.17 (INTERHEART, Lancet 2004)
Diabète	7 pts	HR 2.00 (ERFC, Lancet 2010)
IMC / Obésité	6 pts	HR 1.69 (97 cohortes, Lancet 2014)
Ancien fumeur <5 ans	5 pts	Risque résiduel ~50% (Kenfield, JAMA 2008)
Sédentarité	5 pts	HR 1.90 (AHA, Circulation 2016)
Antécédents familiaux	5 pts	HR 1.74 (EPIC-Norfolk, Heart 2011)
Sexe	5 pts	HR ~2.0 H vs F (EPIC-Norfolk 2024)
Apnée du sommeil	5 pts	HR 1.82 (Dong, Int J Cardiol 2013)

Comment va votre cœur ? - Évaluation Cardiovasculaire

Colères / hostilité	3 pts	HR 1.19-1.50 (Chida, JACC 2009)
Troubles du sommeil	3 pts	HR 1.45 (He, Eur J Prev Cardiol 2017)
Fruits et légumes	3 pts	OR 1.43 (INTERHEART, Lancet 2004)
Ajout de sel	1 pt	RR 1.13 (Graudal, Nutrients 2020)
Préparation des repas	3 pts	RR ~1.50 (Micha et al., Circulation 2010)
Charcuterie/Fromage régulier	3 pts	RR 1.42 (Micha et al., Circulation 2010)
Charge familiale seul(e)	2 pts	HR 1.29 (Valtorta, Heart 2016)
Alcool excessif	3 pts	RR 1.35 (Zhao, JAMA Network Open 2023)
Tabac passif	2 pts	RR 1.25 (He, NEJM 1999)
Activité physique	2 pts	HR 1.24 indépendant (Li & Siegrist, 2012)
Boissons énergisantes	1 pt	Risque d'arythmie / HTA aiguë (Fletcher, JACC 2017)

Références

1. SCORE2 Working Group (ESC). Eur Heart J, 2021;42(25):2439-2454.
2. SCORE2-OP Working Group (ESC). Eur Heart J, 2021;42(25):2455-2467.
3. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention. Eur Heart J, 2021.
4. INTERHEART (Yusuf et al., Lancet 2004) - 52 pays, 27 000 sujets.
5. Prospective Studies Collaboration (Lewington et al., Lancet 2002) - 1M adultes.
6. Emerging Risk Factors Collaboration (Lancet 2010) - 102 études prospectives.
7. Young et al., AHA Science Advisory. Circulation 2016 (sédentarité).
8. Micha et al., Circulation 2010 (alimentation ultra-transformée / viande transformée).
9. Dong et al., Int J Cardiol 2013 (apnée du sommeil).
10. He et al., NEJM 1999 (tabagisme passif).
11. He et al., Eur J Prev Cardiol 2017 (insomnie / troubles du sommeil).
12. Cappuccio et al., Eur Heart J 2011 (durée de sommeil < 6h, synthèses).
13. Chida & Steptoe, JACC 2009 (hostilité / colères).
14. Valtorta et al., Heart 2016 (isolement social).
15. Rosengren et al., Lancet 2004 (facteurs psychosociaux, INTERHEART).
16. Kenfield et al., JAMA 2008 (ancien tabac < 5 ans).
17. Li & Siegrist, Int J Environ Res Public Health 2012 (activité physique).
18. Graudal et al., Nutrients 2020 (sel).
19. Zhao et al., JAMA Network Open 2023 (alcool).
20. Fletcher et al., JACC 2017 (boissons énergisantes).
21. EPIC-Norfolk, Heart 2011 (antécédents familiaux).
22. EPIC-Norfolk, Eur J Prev Cardiol 2024 (sexe / hérédité).
23. Pooled analyses, Lancet 2014 (IMC / surpoids, cohortes).
24. Global BMI Mortality Collaboration, Lancet 2016 (obésité sévère).
25. Prospective Studies Collaboration, Lancet 2007 (cholestérol total par mmol/L).